

통풍 — 꼭 알아야 할 것만

환자분들이 가장 많이 묻는 것

통풍은 혈액 속 **요산**이 많아져 관절 안에 **결정(結晶)**으로 쌓이면서 생깁니다. 그래서 치료도 두 갈래입니다 — **지금의 통증을 가라앉히는 약과, 쌓인 요산을 녹여내는 약**. 이 두 가지를 구분해서 아시면 통풍 치료의 절반은 이해하신 것입니다.

지금 발작이 왔다면

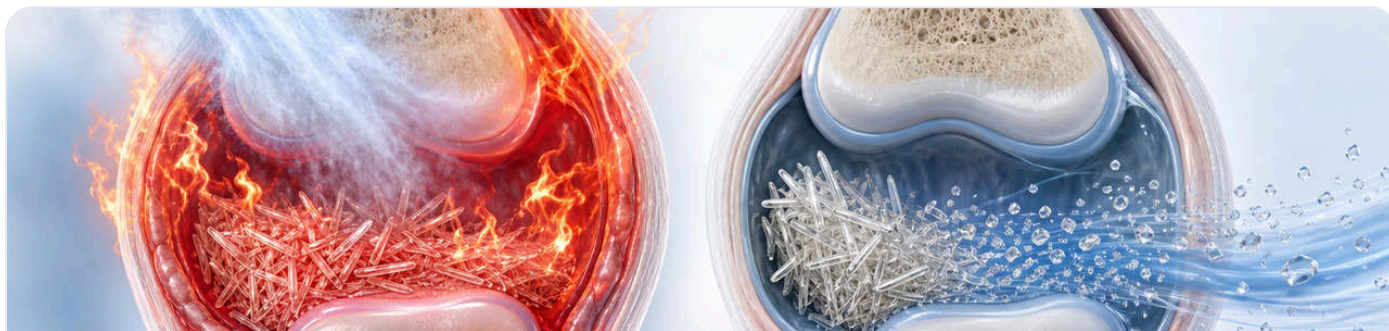
먼저 이 네 가지

- 1 빨리 알려주세요.** 발작이 시작되면 되도록 빨리 병원에 알리고 진료를 받습니다.
- 2 관절을 쉬게 하세요.** 다치지 않게 쓰지 말고, **냉찜질**을 합니다.
- 3 핫팩·온찜질은 하지 마세요.** 혈관이 넓어져 염증이 오히려 심해집니다.
- 4 먹던 요산 생성 억제제는 끊지 마세요.** 그대로 드시면서 통증 약을 함께 씁니다.

아플 때 쯤 요산 수치는 낮게 나올 수 있습니다. 그 수치 하나만으로 통풍이 아니라고 단정할 수 없어, 통증이 완전히 가라앉은 뒤에 다시 검사해 정확한 값을 확인합니다.

약이 두 종류인 이유 — 불끄기 약과 청소 약

비교	불끄기 약 (급성기 치료)	청소 약 (요산 생성 억제제)
무엇을 하나	지금의 통증과 염증 을 가라앉힙니다	관절에 쌓인 요산 결정 을 서서히 녹여냅니다
어떤 약	콜히친 · 소염진통제 · 스테로이드	알로푸리놀 · 페복소스타트 등
언제 먹나	발작이 왔을 때 짧게	매일 꾸준히 — 고혈압 약처럼 오래
발작이 오면	이 약을 시작합니다	끊지 않습니다 — 그대로 계속
언제 끝나나	발작이 가라앉으면 중단	목표에 도달해도 대개 계속 (결정이 천천히 녹기 때문)



왼쪽 — 지금의 염증을 가라앉히는 작용(불끄기) · 오른쪽 — 쌓인 요산 결정을 녹여 내보내는 작용(청소)

발작에 쓰는 약은 세 가지

효과는 서로 대등합니다

어느 약이 더 센가가 아니라, **지금 내 몸 상태에 가장 안전한 약**이 무엇인지로 고릅니다. 콩팥 기능, 위장 질환, 당뇨, 심혈관 질환에 따라 선택이 달라집니다.

약	이런 분께 잘 맞습니다	알아두실 점
콜히친	대부분의 환자에서 우선 고려 — 적은 용량으로 씁니다	설사·복통이 있을 수 있고, 함께 먹으면 안 되는 약 이 있어 드시는 약을 모두 알려주세요
소염진통제 (NSAID)	콩팥·위장에 문제가 없는 분	콩팥에 부담을 주거나 위장 출혈·부종·혈압 상승이 올 수 있습니다
스테로이드	콩팥이 안 좋거나, 위장이 약하거나, 여러 관절이 함께 아픈 분	혈당이 일시적으로 오를 수 있어 당뇨약을 드시는 분은 미리 말씀해 주세요

요산 약 · 위험 신호 · 음식

요산 생성 억제제, 언제 시작해서 얼마나 먹나요

1 **이럴 때 시작합니다.** 통풍결절이 있거나, 발작이 **한 해 두 번 이상** 올 때.

2 **보통 발작이 가라앉은 뒤** 2~4주쯤에 시작합니다. 드시던 분은 발작 중에도 계속.

3 **대부분 오래 드십니다.** 끊으면 다시 쌓여 재발하므로, 중단은 진료 때 상의합니다.

4 **알로푸리놀 전 유전자검사를** 권합니다. 한국인은 이 유전자를 가진 비율이 서양인보다 높습니다.

유전자검사(HLA-B*58:01)에서 **양성**이면 알로푸리놀 대신 페복소스타트 같은 다른 약을 씁니다. **음성**이라고 위험이 완전히 없어지는 것은 **아니므로**, 약을 드시다 발진이 생기면 바로 알려 주세요.

“약을 시작했는데 오히려 더 아파요”

요산이 빠르게 떨어지는 초기에는 발작이 오히려 생길 수 있습니다. 약이 안 맞아서가 아닙니다. 그래서 ①**적은 용량으로 시작해** 천천히 올리고, ②**발작을 막는 약을 최소 3~6개월 함께** 드십니다.

목표 수치와 검사 간격

혈중 요산 목표는 **6 mg/dL 미만**입니다. 통풍결절이 있으면 더 낮게(**5 mg/dL 미만**) 잡기도 합니다. 검사는 **약을 시작하거나 올리는 동안 2~5주 간격**, 목표에 도달해 안정되면 **6개월 간격**입니다. 증상만 보지 않고 **수치를 확인하며** 약을 조절하고, 콩팥·간 기능도 함께 봅니다.

이런 신호가 오면 바로 오세요

참지 마시고 연락

드시는 약	이런 신호가 오면
요산 생성 억제제 알로푸리놀·페복소스타트	원인 모를 열 · 피부 발진(특히 번지거나 물집) · 입안이 험을 · 눈 충혈 · 얼굴 부종 → 즉시 중단하고 오세요
콜히친	멈추지 않는 심한 설사 , 쥐어짜는 듯한 복통, 근육 통증
소염진통제	검은 변 · 피를 토함 (위장 출혈), 소변량이 크게 줄거나 몸이 붓는 경우 (콩팥)
스테로이드	혈당이 평소보다 높아짐, 잠이 안 오거나 기분 변화, 감염 징후
약과 상관없이	열이 나면서 여러 관절이 아프고 몸이 몹시 처질 때 — 감염 여부를 가려야 하므로 바로 오세요

* 약 이상반응은 검사 수치보다 **몸이 먼저 알려줍니다**. 위 신호가 보이면 참고 견디지 마시고 바로 연락 주세요.

무엇을 먹고, 무엇을 줄일까

드셔도 됩니다

제한할 근거가 없습니다

- 콩 · 두부 · 버섯 · 시금치 — 식물성 퓨린은 발작을 늘리지 않습니다
- 저지방 우유 · 요거트
- 커피, 그리고 충분한 **수분**

양을 조절하세요

끊기보다 줄이기

- **붉은 고기**는 살코기 위주로 적정량 나눠서
- **내장류 · 진한 곰탕 국물**은 피하세요
- **해산물**은 적당한 양으로. **등푸른생선**은 심장에 좋으니 유지

줄이는 것이 좋습니다

근거가 가장 뚜렷합니다

- **술** — 맥주가 가장 위험하지만 **소주도 요산을 올립니다**
- **콜라 · 주스 · 에너지링크** 같은 단 음료
- **굵는 다이어트 · 극단적 저탄고지**는 발작을 부릅니다 — 체중은 천천히

* **체리·비타민C 보충제로 통풍을 치료할 수는 없습니다**. 음식 조절만으로 낮출 수 있는 요산에도 한계가 있어, 처방받은 약과 함께 가야 합니다.

